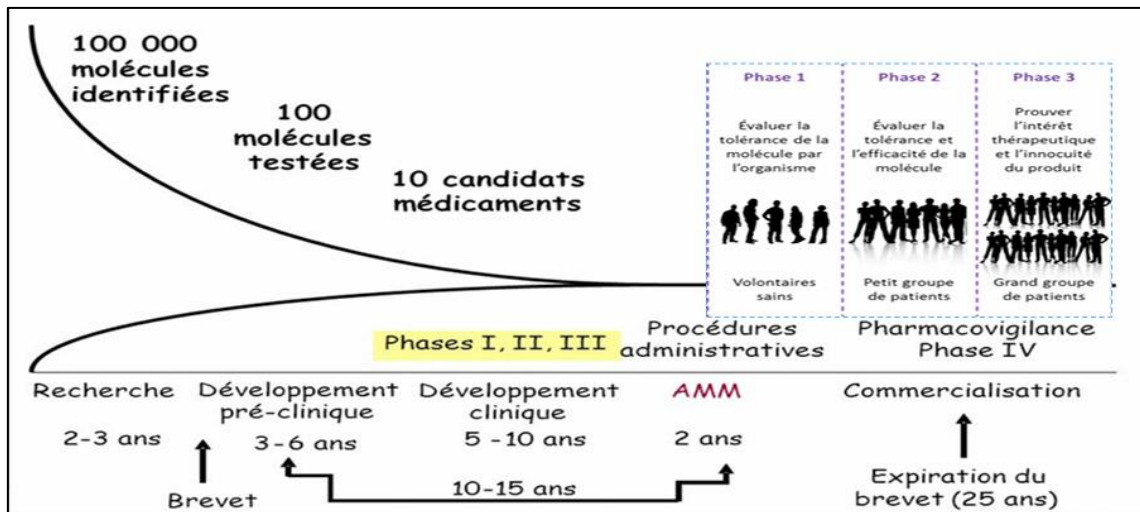


LA PHARMACOVIGILANCE

Introduction :



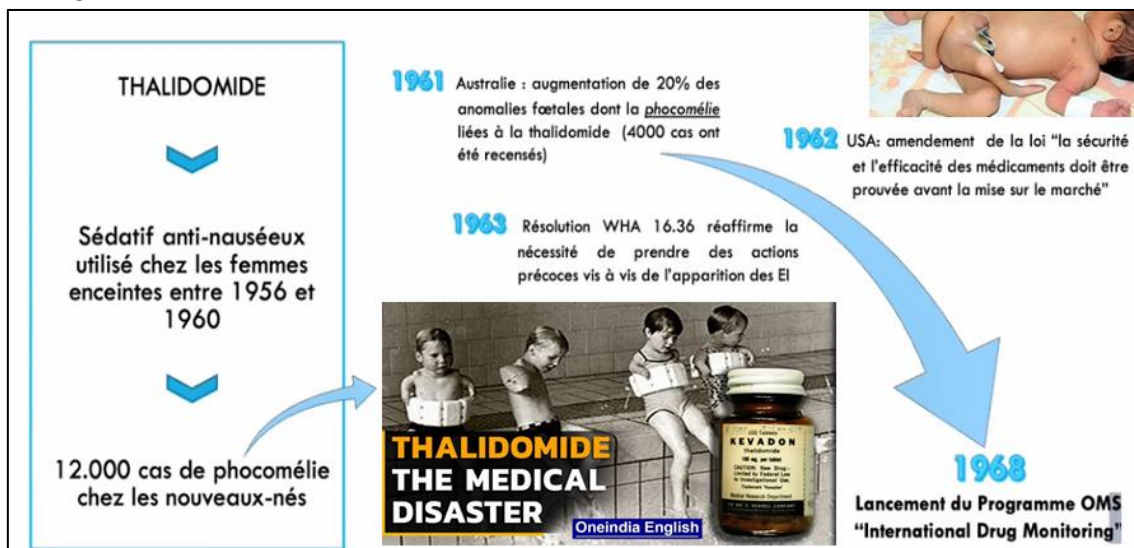
LIMITES DES ESSAIS CLINIQUES :

- ❖ Le nombre de sujets inclus dans les essais cliniques est limité.
- ❖ Les Sujets à risque sont écartés : enfants, personnes âgées, femme enceinte, IR, IH.
- ❖ Absence d'information sur les effets d'une prise chronique des médicaments ainsi que sur et les IAM.
- ❖ Déroulement en milieu hospitalier où certains facteurs de risque (irrégularités des prises, l'alimentation ou l'alcool) sont minimisés.
- ❖ Faible fréquence des effets indésirables graves :
 - Pénicilline : 1 choc anaphylactique / 47500Inj.
 - 1 décès/100000patients.

DÉFINITION :

- ❖ La pharmacovigilance est une Science ou ensemble d'activités relatives à la détection, l'évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments.

HISTORIQUE :



Objectifs de la pharmacovigilance :

- ❖ Déceler aussi précocement que possible les effets indésirables graves et inattendus dus aux médicaments nouvellement introduits en thérapeutique.
- ❖ Établir la fréquence et la gravité des effets indésirables connus.
- ❖ Identifier les facteurs de risque et des mécanismes pouvant expliquer ces effets.
- ❖ Evaluer, quantifier, minimiser et prévenir le risque médicamenteux.
- ❖ Diffuser l'information nécessaire à l'amélioration de la prescription et de la réglementation du médicament.

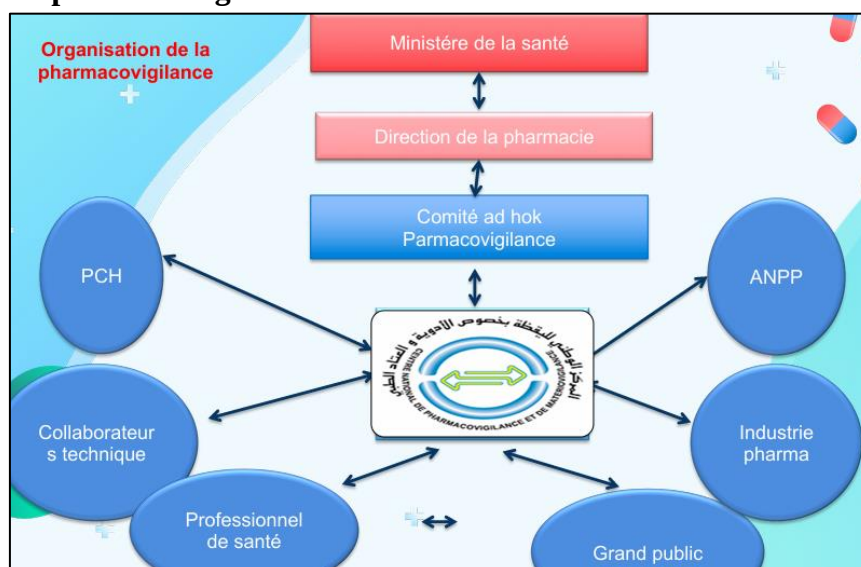
Autres types de vigilances :

- ❖ **Hémovigilance** : Ensemble des procédures de surveillance, d'évaluation et de prévention des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles (PSL).
- ❖ **Matéiovigilance** : Suivi des dispositifs médicaux et matériels implantables
- ❖ **Biovigilance** : contrôle et suivi de qualité et de l'innocuité des tissus et cellules employés pour les greffes
- ❖ **Réactovigilance** : réactifs de laboratoire.
- ❖ **Cosmétovigilance** : cosmétiques.
- ❖ **Phytovigilance** : les plantes.

Moyens d'intervention en PV :

- ❖ **Retrait de l'AMM** :
 - ✓ Le plus souvent, ce sont les firmes elles-mêmes qui retirent leur produit de la vente dès que des faits inquiétants de pharmacovigilance sont signalés quelque part dans le monde.
- ❖ **Suspension de l'AMM** :
 - ✓ Pour permettre (le plus souvent en accord avec la compagnie) le développement d'une enquête sur un effet dangereux éventuel.
- ❖ **Modification des conditions d'utilisation** :
 - ✓ Restriction aux indications thérapeutiques, formulation de contre-indications, de précautions d'emploi, de mise en garde.
- ❖ **Mise à jour de l'information des médecins et des pharmaciens** :
 - ✓ En particulier par la révision, en accord avec le laboratoire, du « RCP » et de la monographie du Dictionnaire Vidal.

Organisation de la pharmacovigilance :



Processus de la pharmacovigilance (PV) :

A- Recueillir les données

B- Evaluer les données

C- Etudier les effets indésirables : Imputabilité

D- Informer l'organisme d'autorité

1. Notification :

❖ Notification spontanée :

- ✓ Signalisation à un centre de pharmacovigilance des EIM suspectés suite à la prise d'un ou de plusieurs mdts sur déclaration volontaire par le personnel de santé : médecins, pharmaciens, médecins-dentistes, infirmiers, sages-femmes. Parfois par le malade lui-même.

❖ Notification Orientée :

- ✓ Il se fait dans le cadre d'**enquêtes structurées** en fonction d'**objectifs plus précis** qui sont souvent déclenchées à la suite d'alertes suscitées par des notifications spontanées.

A quels produits ?

- ❖ Spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une **AMM**.
- ❖ Spécialité pharmaceutique faisant objet d'une **ATU (autorisation temporaire d'utilisation)**.
- ❖ Préparations **magistrales, hospitalières et officinales**.
- ❖ Médicaments **homéopathiques**.
- ❖ Médicaments **dérivés du sang (produits sanguins stables)**.
- ❖ Les **dispositifs médicaux** dans le cadre de la matériovigilance.

Quel effet doit-on déclarer ?

- ❖ Tout **effet indésirable grave** (létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou prolongeant une hospitalisation ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale).
- ❖ Tout **effet inattendu** dont la nature, la sévérité, la fréquence ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le RCP.

Qui doit déclarer ?

- ❖ Médecin
- ❖ Pharmacien
- ❖ Infirmier
- ❖ Patient

COMMENT DÉCLARER ?

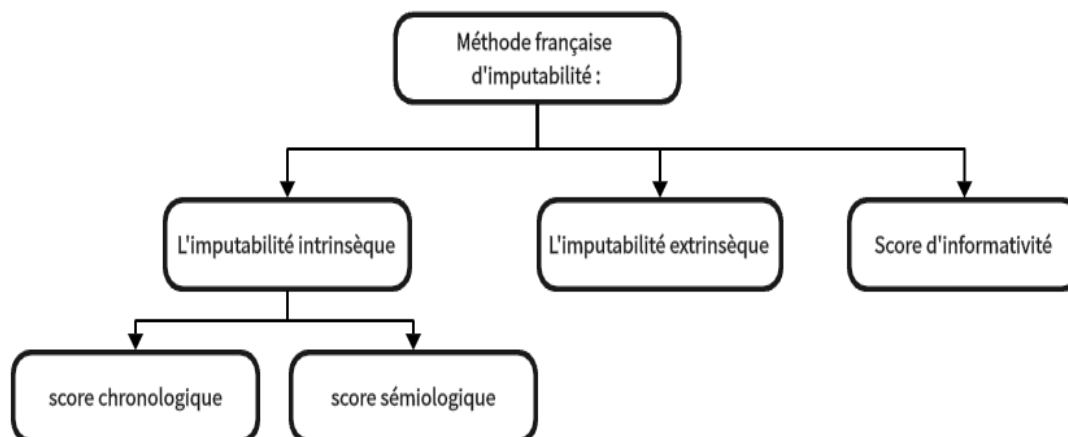
A l'aide de la fiche de pharmacovigilance

Service d'Oncologie Médicale Pr FILLALI						Description de la réaction indésirable	
FICHE DE DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES							
Patient							
Nom : Prénom : Sexe : ☐ F ☐ M ☐		Age : Poids : Taille :		N° dossier : Adresse : N° Tél :		Localisation / type de protocole	
Antécédents / comorbidité :							
Notificateur						Traitement de la réaction :	
Nom et prénom :			Email :			Date et durée de l'effet	
Médecin ☐ Pharmacien ☐ Infirmier ☐			Cachet et signature :			Durée de l'effet :	
Service :			Date de déclaration :			Gravité	
Médicament						Evolution	
Nom commercial ou DCI		Posologie et voie d'administration		Date de début de prise		Gradation	
				Date de fin de prise		Type de grade :	
				Nom du fabricant et N° lot		Précisez l'échelle utilisée :	
				Indication			
Un ou des produits ont-ils été arrêtés ?						Un ou des produits ont-ils été réintroduits ?	
Non ☐ oui ☐ le(s)quel(s) :						Non ☐ oui ☐ le(s)quel(s) :	

2. Calcul de l'imputabilité :

- ❖ On entend par ce terme, la **probabilité pour qu'il existe une relation de cause à effet** entre l'**administration médicamenteuse** et l'**effet indésirable**, et si la réponse est positive, le degré de responsabilité du médicament.

Méthode française d'imputabilité :



A. L'imputabilité intrinsèque :

❖ LES CRITÈRES CHRONOLOGIQUES (C) :

1. Délai de l'événement suivant Indésirable par rapport à la prise du médicament
2. Evolution de l'effet à l'arrêt du médicament
3. notion Réadministration du médicament

ADMINISTRATION DU MEDICAMENT	Délai d'apparition de l'effet						
	Très suggestif ou Suggestif			Compatible			
Évolution de l'effet	Ré administration						
	R(+)	R(0)	R(-)	R(+)	R(0)	R(-)	
« suggestive » : régression de l'effet à l'arrêt du médicament avec ou sans traitement symptomatique (avec un recul suffisant et en prenant en compte les caractéristiques pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques du médicament) ou lors de la diminution de posologie pour un effet dose-dépendant.	C3	C3	C1	C3	C2	C1	C0
« non concluante » : - lésions irréversibles ou décès - évolution inconnue - recul insuffisant après l'arrêt du médicament - persistance de l'effet et médicament non arrêté - persistance de l'effet après administration unique	C3	C2	C1	C3	C1	C1	
« non suggestive » : - absence de régression de manifestations de type réversible malgré l'arrêt avec un recul suffisant - régression complète malgré la poursuite du médicament	C1	C1	C1	C1	C1	C1	

Très suggestif : ex : choc anaphylactique après Quelques minutes

Incompatible : délai insuffisant pour que l'événement apparait ; événement apparu avant prise du médicament

Compatible : autres cas

R+ : réadministration positif, l'événement récidive,

R0 : réadministration non faite ou non évaluable

R- : réadministration négatif, l'événement ne récidive pas

Très suggestif : ex : choc anaphylactique après Quelques minutes

Incompatible : délai insuffisant pour que l'événement apparait ; événement apparu avant prise du médicament

Compatible : autres cas

R+ : réadministration positif, l'événement récidive,
R0 : réadministration non faite ou non évaluable
R- : réadministration négatif, l'événement ne récidive pas

C3 : Vraisemblable

C2 : Plausible

C1 : Douteux

C0 : Incompatible

❖ **CRITÈRES SÉMIOLOGIQUES (S) :**

1. Symptomatologie clinique et paraclinique évocatrice
2. Autres causes non médicamenteuses
3. Examens spécifiques

Sémiologie clinique et paraclinique	Evocatrice* du rôle de ce médicament ET facteur favorisant bien validé du couple effet indésirable/ médicament	Evocatrice* du rôle de ce médicament ET/OU facteur favorisant bien validé du couple effet indésirable/ médicament	Ni sémiologie évocatrice* du rôle de ce médicament ni facteur favorisant bien validé						
	* évocatrice en raison : des propriétés pharmacologiques du médicament, de signes évocateurs d'un syndrome de sevrage, de la localisation des effets observés								
Autres causes non médicamenteuses	Examens complémentaires								
	indésirable/médicament ou réponse à un antidote spécifique								
	L(+)	L(0)	L(-)	L(+)	L(0)	L(-)	L(+)	L(0)	L(-)
Absente après bilan approprié	S3	S3	S2	S3	S3	S1	S3	S2	S1
Non recherchée (ou bilan incomplet)	S3	S3	S1	S3	S2	S1	S3	S1	S1
Présente	S2	S2	S1	S2	S1	S1	S1	S1	S0

S3 : Vraisemblable

S2 : Plausible

S1 : Douteux

S0 : peu plausible voire exclu

❖ **Combinaison des scores :**

COMBINAISON DES SCORES CHRONOLOGIQUE ET SÉMIOLOGIQUE	SCORE D'IMPUTABILITÉ INTRINSÈQUE
C0 ou S0	I 0
C1S1	I 1
C1S2	I 2
C2S1	I 2
C2S2	I 3
C1S3	I 4
C3S1	I 4
C2S3	I 5
C3S2	I 5
C3S3	I 6

B. L'imputabilité extrinsèque :

B4	effet attendu RCP
B3	effet référencé ou largement publié
B2	effet publié une ou deux fois dans un journal
B1	effet non publié conformément aux définitions de B3 ou B2.

C. Score d'informativité :

- ❖ Pour des médicaments ayant un score d'imputabilité intrinsèque identique, les niveaux d'informativité peuvent être différents, quelle que soit la source d'information.
- ❖ Ainsi, pour chaque couple effet indésirable-médicament, le niveau d'informativité est classé en trois catégories **NI 2, NI 1 et NI 0**, en fonction des informations disponibles.

a) **délai de survenue de l'effet indésirable** par rapport à la période d'exposition au médicament

b) **notion d'arrêt ou de poursuite du médicament ou de modification de posologie.**

N0	les éléments a et b ne sont pas renseignés.
N1	l'un des éléments a ou b n'est pas renseigné.
N2	Les éléments a et b sont renseignés.